胰脂肪酶分解甘油三酯产生脂肪酸(有毒性,可直接损伤胰腺),高胆固醇血症是错的

⑥腹部外伤：方向盘伤、车把伤

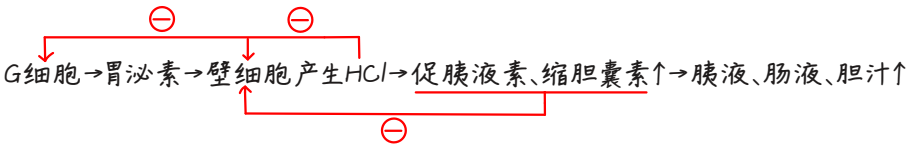
⑦高脂血症尤其血甘油三酯≥11.3mmol/L：急性胰腺炎与脂肪肝互为因果 急性胰腺炎→脂代谢紊乱→脂肪肝

⑧高钙血症：甲状旁腺肿瘤、维生素 D 过多 肠系膜上A栓塞

⑨房颤：房颤患者若出现急腹症需考虑绞窄性肠梗阻、急性胰腺炎 胰腺供血动脉栓塞

⑩其它：药物（糖皮质激素、阿糖胞苷、对乙酰氨基酚、磺胺、四环素、利尿剂、雌激素、美沙拉嗪、硫唑嘌呤和巯嘌呤等）；柯萨奇病毒等感染；异常免疫反应等 GC可促进胃酸分泌→促胰液素、缩胆囊素↑→胰液↑↑→胰管压力↑

外科病例题:房颤病史+突发急腹症→考虑附壁血栓脱落引起的绞窄性肠梗阻、急性胰腺炎



三、病理分型和临床病情程度

（一）病理分型

①水肿型/轻型（多见）：没有胰腺坏死、或仅有轻微局部坏死

②出血坏死型/重型：胰腺及其周围脂肪组织坏死、出血严重、灰白色钙皂、并发症多见

（二）临床病情程度

	轻症	中重症	重症	危重
器官衰竭 （依据呼吸、循环、肾功能评价）	无	≤48 小时 一过性	＞48 小时	＞48 小时
	和	和/或	或	和
胰腺坏死（CT）	无	无菌性	感染性	感染性

CT是胰腺很重要的检查

四、临床表现和并发症



1.**暴饮暴食（最常见诱因）、大量饮酒后突发上腹痛**

①多为上、中腹偏**左**痛 胰腺炎以胰腺的体、尾部多见

②常剧烈、呈**持续性**

③可向**左**肩及**腰背部**放射（束带感） 本来就在腹膜后(胰腺、十二指肠球后溃疡)、慢性穿孔/穿透性溃疡

④伴恶心呕吐、**呕吐后腹痛不缓解**

（呕吐后不缓解先考虑急性胰腺炎、急性完全性输入袢梗阻、碱性反流性胃炎等）

⑤取弯腰抱膝位可减轻 减轻腹部压力

⑥血钙降低时可有手足抽搐 Ca^{2+}↓→膜屏障作用↓→膜电位与阈电位变近→兴奋性↑

⑦多无黄疸，但结石嵌顿或胰头肿大压迫胆总管可出现黄疸

引起急性胰腺炎的结石多为一过性,停留在肝胰壶腹一段时间后就脱落



2.明显炎性渗出至腹腔时：

①广泛明显的压痛、反跳痛、肌紧张，移动性浊音，肠鸣音↓

②腹膜后炎症越重→**腹胀**越明显（提示**病情越严重**）

麻痹性肠梗阻→肠内积气↑

3.坏死出血时：血性腹水；皮肤呈青/蓝紫色瘀斑（在腰、季肋/侧、下腹部为 **Grey-Turner 征**，在肚脐周围为 **Cullen 征** 窟窿-肚脐）

发热、腹痛、血性腹水可见于:重症胰腺炎、结核性腹膜炎、肝癌、门静脉血栓形成